

CAPÍTULO 6.10

Control de la Diabetes en el Embarazo

PERFIL EUNACOM 1.04.2.002

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

# Control Obstétrico en Diabetes Gestacional y Pregestacional

Complicaciones fetales/neonatales de la DMG

| TABLA 6.10.1: COMPLICACIÓN VS MECANISMO |                                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| COMPLICACIÓN                            | MECANISMO                                                       |
| Macrosomía fetal (> 4.500 g)            | Hiperglicemia → hiperinsulinemia fetal → crecimiento excesivo   |
| Hipoglicemia neonatal                   | ↑ insulina fetal persiste post-parto                            |
| Hipocalcemia neonatal                   | Puede simular hipoglicemia → medir calcio siempre               |
| Distocia de hombros                     | Mayor riesgo a igual peso que no diabética                      |
| Poliglobulia neonatal                   | Insulina fetal actúa como factor de crecimiento eritrocítico    |
| Polihidramnios                          | Glucosuria fetal → poliuria fetal → exceso de líquido amniótico |
| Enfermedad de membrana hialina          | Maduración pulmonar retrasada (especialmente < 34 sem o DMPG)   |

Complicaciones adicionales en DMPG

- Malformaciones del tubo neural (anencefalia, espina bífida, meningocele)
- Insuficiencia placentaria → RCIU, preeclampsia, oligoamnios

EUNACOM CRITERIOS

Recién nacido hijo de madre diabética con síntomas de "hipoglicemia" pero glicemia normal → medir **calcio** (hipocalcemia neonatal).

Interrupción del embarazo

- Semanas recomendadas: 39–41 semanas
- Vía de parto: vaginal de preferencia

- Cesárea electiva si: peso fetal > **4.500 g** (en DM pregestacional: > 4.000–4.500 según contexto)

Prevención

- Ácido fólico **4 mg/día** durante toda la gestación (no 0,4 mg → dosis 10 veces mayor)

Post-parto (para la madre)

- TTOG a las **6–12 semanas** post-parto
- Objetivo: descartar DM2 de base (DMG aumenta riesgo futuro)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Embarazada con DM pregestacional consulta para control en semana 12. Monitoreo capilar: ayuno 85 mg/dL, 1h postprandial 115 mg/dL, 2h postprandial 105 mg/dL."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Metas de Control Glicémico en Embarazo: Glicemia en ayunas < 95 mg/dL, 1 hora postprandial < 140 mg/dL, y 2 horas postprandial < 120 mg/dL. El control estricto previene macrosomía fetal, polihidramnios, preeclampsia y distocia de hombros.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La macrosomía fetal es la complicación más frecuente de la diabetes gestacional
- Las malformaciones congénitas ocurren solo en diabetes pregestacional mal controlada en el primer trimestre
- HbA1c meta en embarazo: menor a 6% ideal, menor a 6.5% máximo
- Automonitoreo glicémico al menos 4 veces al día
- Monitorización fetal anteparto desde las 32-34 semanas
- DG con dieta: parto hasta 40 semanas; DG con insulina: 38-39 semanas
- Durante el parto mantener glicemia entre 70-120 mg/dL

## EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (CONTROL DE LA DIABETES EN EL EMBARAZO)

## PREGUNTA 1

Paciente con diabetes pregestacional tipo 1, HbA1c de 9% al inicio del embarazo. ¿Cuál es la complicación fetal más asociada a esta situación?

- A) Macrosomía fetal
- B) Malformaciones congénitas
- C) Hipoglicemia neonatal
- D) Polihidroamnios
- E) Restricción del crecimiento intrauterino

## PREGUNTA 2

Embarazada de 36 semanas con diabetes gestacional en tratamiento con insulina, bien controlada. ¿Cuál es la conducta obstétrica más adecuada respecto al momento del parto?

- A) Interrupción inmediata a las 36 semanas
- B) Interrupción entre las 38-39 semanas
- C) Esperar inicio espontáneo del trabajo de parto
- D) Cesárea electiva a las 37 semanas
- E) Interrupción a las 41 semanas

## PREGUNTA 3

Durante el trabajo de parto de una paciente diabética, ¿cuál es el rango de glicemia que se debe mantener?

- A) 60-80 mg/dL
- B) 70-120 mg/dL
- C) 120-180 mg/dL
- D) 80-200 mg/dL
- E) 100-140 mg/dL

## RESUMEN: CONTROL DE LA DIABETES EN EL EMBARAZO

El control metabólico estricto durante el embarazo en pacientes diabéticas es esencial para prevenir complicaciones maternas y fetales. Las complicaciones fetales incluyen macrosomía, hipoglicemia neonatal, hiperbilirrubinemia, policitemia, síndrome de distrés respiratorio y malformaciones congénitas (estas últimas solo en diabetes pregestacional mal controlada en el primer trimestre). Las complicaciones maternas incluyen preeclampsia, polihidroamnios, infecciones urinarias y cesárea. El control se basa en el automonitoreo glicémico con al menos 4 mediciones diarias. La hemoglobina glicosilada debe mantenerse menor a 6% idealmente, o menor a 6.5% como máximo. Se recomienda control obstétrico cada 2 a 4 semanas, con ecografía para evaluar crecimiento fetal, líquido amniótico y bienestar fetal. La monitorización fetal anteparto se inicia desde las 32 a 34 semanas. El momento del parto depende del control metabólico y las complicaciones. En diabetes gestacional bien controlada con dieta, se puede esperar hasta las 40 semanas. Si requiere insulina, se recomienda interrupción entre las 38 y 39 semanas. Durante el trabajo de parto se debe mantener la glicemia entre 70 y 120 mg/dL con infusión de insulina y glucosa según necesidad.